

Fundamentos y lineamientos para la atención integral en salud de las violencias sexuales

Breve descripción:

Este componente formativo desarrolla los fundamentos conceptuales, normativos y procedimentales de la atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales, conforme a la normatividad vigente y al contexto del servicio de salud. Fortalece competencias para aplicar modelos, protocolos y enfoques de derechos humanos, género, diferencial y ciclo vital, garantizando una atención ética, digna, oportuna y libre de revictimización.

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Violencias sexuales como problema de salud pública y social	8
1.1. Concepto de violencias sexuales	9
1.2. Impacto de las violencias sexuales en la salud física, mental y social	11
1.3. Rol del sector salud y del talento humano en la atención integral	12
2. Marco conceptual	15
2.1. Violencias sexuales y derechos humanos	15
2.2. Violencias y salud sexual y reproductiva	17
2.3. Tipologías de las violencias sexuales	18
3. Caracterización epidemiológica de las violencias sexuales	21
3.1. Magnitud y comportamiento de las violencias sexuales	21
3.2. Violencias sexuales como evento de interés en salud pública	23
3.3. Distribución de las violencias sexuales según contexto de ocurrencia ..	24
3.4. Factores de riesgo asociados a las violencias sexuales	27
3.5. Subregistro y barreras de acceso a los servicios de salud	28
4. Marco normativo de la atención integral	32
4.1 Instrumentos internacionales aplicables	32
4.2 Normativa nacional sobre violencias sexuales	35

4.3	Normativa del sector salud aplicable a la atención integral	39
4.4	Derechos de las víctimas de violencias sexuales en el sector salud	42
4.5	Responsabilidades del talento humano en salud	43
5.	Enfoques para la atención integral frente a la violencia sexual	46
5.1	Enfoque de derechos humanos	46
5.2	Enfoque de género	47
5.3	Enfoque diferencial y de ciclo vital	49
5.4	Enfoque psicosocial	49
5.5	Prevención de la revictimización	50
6.	Proceso de atención integral en salud	52
6.1	Principios del proceso de atención integral	53
6.2	Recepción y atención inicial de la persona víctima	55
6.3	Evaluación del estado general y del riesgo vital	58
6.4	Valoración clínica integral	59
6.5	Procedimientos médicos y medidas terapéuticas complementarias	63
6.6	Orientación diagnóstica inicial	65
6.7	Seguimiento, referencia y contrarreferencia	67
7.	Articulación intersectorial y rutas de atención	69
7.1	Articulación intersectorial en la atención integral	69

7.2	Consentimiento informado	71
7.3	Manejo ético de la información	73
7.4	Responsabilidad ética y legal del talento humano	75
Síntesis		77
Glosario		78
Referencias bibliográficas		80
Créditos		83

Introducción

Las violencias sexuales constituyen una grave violación a los derechos humanos y un problema prioritario de salud pública, debido a su alta prevalencia y a las profundas afectaciones que generan en la salud física, mental y social de las personas víctimas, sus familias y la comunidad. Estas violencias impactan de manera diferencial a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y requieren una respuesta integral, oportuna, ética y humanizada por parte del sector salud.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Fundamentos y lineamientos para la atención integral en salud de las violencias sexuales



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video: Fundamentos y lineamientos para la atención integral en salud de las violencias sexuales

En Colombia, todo caso de violencia sexual es una urgencia médica, sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho. Esto significa que el sector salud tiene la obligación de brindar atención inmediata, integral y completamente gratuita a la víctima, eliminando cualquier barrera administrativa, económica o institucional que impida su acceso a los servicios, tal como lo establece la Resolución 459 de 2012.

Atender a una víctima de violencia sexual va mucho más allá de la consulta clínica. Requiere un enfoque integral que reconozca a la persona como sujeto de derechos y que articule la atención médica con el acompañamiento emocional, la protección y el acceso a la justicia.

Para lograrlo, el talento humano en la salud debe actuar con confidencialidad, obtener el consentimiento informado, garantizar un trato digno y evitar cualquier práctica que revictimice a la persona atendida.

En este proceso, el personal de salud cumple un rol esencial: detectar tempranamente la violencia sexual, activar las rutas de atención intersectorial y contribuir al restablecimiento de los derechos vulnerados, todo ello en concordancia con el marco normativo nacional e internacional vigente.

Este curso brinda los conocimientos y herramientas necesarios para comprender el fenómeno de la violencia sexual, identificar sus manifestaciones en los diferentes contextos de atención y responder de forma adecuada, con una atención oportuna, digna y humanizada.

Todo ello, con una atención centrada en los derechos humanos, el bienestar integral y la dignidad de cada persona víctima, como principios fundamentales que guían la práctica del talento humano en la salud.

1. Violencias sexuales como problema de salud pública y social

Las violencias sexuales constituyen un problema social y de salud pública debido a su alta prevalencia, a la diversidad de formas en que se manifiestan y a las graves consecuencias que generan en la salud y el bienestar de las personas, así como en sus familias y comunidades. Su impacto trasciende el ámbito individual y se extiende al tejido social, afectando la cohesión comunitaria y el desarrollo social.

Desde la perspectiva de la salud pública, las violencias sexuales se asocian con múltiples afectaciones que pueden presentarse de manera inmediata o a largo plazo, incrementando la carga de enfermedad y la demanda de servicios sociales y sanitarios. Estas consecuencias inciden de forma directa en la calidad de vida y en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Entre los principales impactos de las violencias sexuales se encuentran:

- Infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.
- Embarazos no deseados.
- Afectaciones en la salud mental y emocional.
- Discapacidad y deterioro del bienestar general.
- Mortalidad prematura en algunos casos.

Las violencias sexuales no ocurren de manera aislada ni fortuita, sino que se producen en contextos sociales caracterizados por desigualdades estructurales, relaciones asimétricas de poder, estereotipos de género, discriminación y exclusión social. Estas condiciones favorecen la reproducción de la violencia y limitan las posibilidades de prevención y protección.

Reconocer las violencias sexuales como un problema social y de salud pública implica comprender su carácter estructural, su impacto colectivo y la necesidad de analizarlas más allá del hecho individual, como una problemática que requiere atención prioritaria desde las políticas públicas y los sistemas de información en salud.

1.1. Concepto de violencias sexuales

Las violencias sexuales constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y un problema de salud pública de alta relevancia, debido a su magnitud, persistencia y a las profundas afectaciones que generan en la vida, la salud y la dignidad de las personas que las experimentan. Estas violencias no se explican como hechos aislados, sino como expresiones de relaciones desiguales de poder, construidas histórica y culturalmente, que permiten el control, la dominación y la instrumentalización del cuerpo y la sexualidad de otras personas.

Desde una perspectiva integral, las violencias sexuales trascienden el acto físico y comprenden un conjunto de conductas que afectan la autonomía sexual, la integridad corporal, la libertad, la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Su ocurrencia puede darse en cualquier ámbito público o privado y afectar a personas de todas las edades, sexos, orientaciones sexuales, identidades de género y condiciones sociales, aunque su impacto es mayor en poblaciones que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual se define como:

- Todo acto sexual, intento de consumir un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones orientadas a comercializar, utilizar o controlar la sexualidad de una persona, mediante coerción, intimidación, amenaza, fuerza física, abuso de poder u otros mecanismos que anulen o limiten la voluntad personal, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor y del ámbito en el que ocurra.

En el marco normativo colombiano, la Ley 1257 de 2008 define la violencia sexual como:

- Toda acción que cause daño o sufrimiento sexual, entendida como la imposición de contacto sexual, físico o verbal, o la participación en interacciones sexuales no consentidas, mediante fuerza, intimidación, manipulación, amenaza, abuso de poder o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad, incluyendo la obligación de realizar estos actos con terceras personas.

Las violencias sexuales se caracterizan por:

- Constituir una relación desigual y asimétrica de poder, en la que una persona impone su voluntad sobre otra.
- Negar la condición de sujeto de derechos de la víctima, reduciéndola a un objeto de dominación o control.

- Presentarse de manera independiente a la existencia de vínculo afectivo, familiar o institucional entre la víctima y el agresor.
- Ocurrir en cualquier contexto familiar, comunitario, laboral, educativo, institucional, en situaciones de conflicto armado o fuera de él.
- Afectar de manera diferenciada a las personas según su edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica, discapacidad o contexto social.

1.2. Impacto de las violencias sexuales en la salud física, mental y social

El carácter integral del impacto de las violencias sexuales en la salud fundamenta su reconocimiento como un problema de salud pública y sustenta la obligación del sector salud de brindar una atención que articule de manera simultánea la valoración clínica física, la atención en la salud mental, el abordaje psicosocial y la orientación en derechos. La normativa vigente establece que esta atención debe prestarse con criterios de oportunidad, calidad, confidencialidad y trato digno, garantizando la autonomía de la persona y evitando prácticas que generen revictimización institucional.

Una atención tardía, fragmentada o limitada únicamente a la intervención inmediata posterior al hecho violento puede generar daños adicionales y profundizar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia sexual. Por esta razón, el talento humano en salud tiene la responsabilidad ética, legal y profesional de reconocer la magnitud del impacto en la salud integral y actuar conforme a los protocolos, modelos y lineamientos vigentes, asegurando una atención humanizada y continua.

Comprender el impacto de las violencias sexuales en las dimensiones física, mental y social permite fundamentar la necesidad de aplicar de manera adecuada los procesos de valoración clínica integral, orientación diagnóstica inicial y activación de las

rutas y protocolos de atención. Estos aspectos constituyen la base para el desarrollo de los apartados posteriores del componente formativo, orientados a fortalecer la atención integral y el restablecimiento de derechos de las personas víctimas de violencias sexuales.

Las violencias sexuales generan afectaciones en la salud física, mental y social. Estas consecuencias requieren atención integral, valoración oportuna y acompañamiento continuo. Entre las principales afectaciones se encuentran las siguientes:

- Lesiones agudas y crónicas
- Riesgo de ITS, VIH y hepatitis B.
- Embarazos no deseados.
- Necesidad de valoración clínica y seguimiento.
- Ansiedad, miedo y culpa
- Depresión y estrés postraumático.
- Ideación suicida.
- Consumo problemático de sustancias.
- Afectación del proyecto de vida
- Estigmatización y aislamiento.
- Ruptura de redes de apoyo.
- Mayor riesgo de revictimización.

1.3. Rol del sector salud y del talento humano en la atención integral

El sector salud cumple un rol esencial en la atención integral de las personas víctimas de violencias sexuales, al constituir con frecuencia el primer punto de contacto

institucional posterior al hecho violento. Esta posición estratégica implica responsabilidades orientadas a garantizar una atención oportuna, ética y digna, de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos establecidos, asegurando la protección de los derechos y la prevención de la revictimización.

El rol del sector salud comprende:

- Garantizar la atención inmediata e integral, sin barreras de acceso ni condicionamiento a la denuncia previa.
- Aplicar los protocolos, modelos y guías de atención vigentes para violencias sexuales.
- Asegurar condiciones de privacidad, confidencialidad y trato digno durante la atención.
- Activar los mecanismos de referencia y contrarreferencia según el nivel de complejidad requerido.
- Articular la atención con las rutas intersectoriales de protección y acceso a la justicia.
- Participar en los procesos de vigilancia en salud pública y notificación de eventos, conforme a los lineamientos establecidos.

Por su parte, el talento humano en salud asume responsabilidades específicas en la atención directa:

- a. Recibir a la persona víctima con empatía, respeto y enfoque de derechos.
- b. Realizar la valoración clínica integral conforme a los protocolos establecidos.
- c. Obtener el consentimiento informado para los procedimientos clínicos y médico-legales.

- d. Brindar orientación clara y oportuna sobre la atención y las rutas disponibles.
- e. Adoptar medidas para prevenir la revictimización institucional.
- f. Registrar la información clínica y administrativa de manera veraz y confidencial.
- g. Coordinar la atención con otros profesionales y sectores cuando sea necesario.

2. Marco conceptual

El marco conceptual de las violencias sexuales permite comprender la naturaleza, alcance y complejidad de este fenómeno, así como sustentar técnica y éticamente la atención integral desde el sector salud. Este capítulo establece las bases conceptuales necesarias para el reconocimiento, análisis y abordaje adecuado de las violencias sexuales, integrando los enfoques de derechos humanos, salud pública y salud sexual y reproductiva, en concordancia con la normativa vigente y los estándares internacionales.

2.1. Violencias sexuales y derechos humanos

Las violencias sexuales constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, en la medida en que afectan de forma directa la dignidad humana, la integridad personal, la libertad, la autonomía y la igualdad. Desde el enfoque de derechos humanos, la atención a las personas víctimas de violencias sexuales trasciende la prestación de servicios de salud y se comprende como una obligación del Estado orientada a la garantía, protección y restablecimiento de derechos, en la cual el sector salud desempeña un papel fundamental.

Las violencias sexuales vulneran, entre otros, los siguientes derechos fundamentales:

- Derecho a la vida y a la integridad física y mental.
- Derecho a la dignidad humana.
- Derecho a la libertad y a la autonomía personal.
- Derecho a la igualdad y a la no discriminación.

- Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- Derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.

Principios del enfoque de derechos humanos en la atención a víctimas de violencias sexuales

El enfoque de derechos humanos orienta la atención en salud hacia la protección de la dignidad, la autonomía y el bienestar integral. En el sector salud, su aplicación implica:

- Reconocer a la persona víctima como sujeto activo de derechos, no como objeto de intervención.
- Garantizar una atención en salud libre de discriminación, estigmatización o trato degradante.
- Respetar la autonomía y la toma de decisiones informadas de la persona.
- Asegurar la confidencialidad de la información clínica y personal.
- Obtener el consentimiento informado para los procedimientos clínicos.
- Promover la participación de la persona en su proceso de atención.
- Implementar medidas institucionales para prevenir la revictimización.

Desde el enfoque de derechos humanos, el sector salud no solo debe atender las consecuencias clínicas de la violencia sexual, sino también contribuir al restablecimiento de derechos mediante la orientación adecuada, la activación de las rutas de protección y justicia y la adopción de prácticas institucionales éticas y humanizadas. La omisión, negligencia o atención inadecuada puede constituir una forma adicional de vulneración de derechos, conocida como revictimización institucional.

El enfoque de derechos humanos orienta de manera transversal la actuación del talento humano en salud y constituye un eje central de la atención integral a las personas víctimas de violencias sexuales, garantizando que la respuesta institucional se centre en sus necesidades, su dignidad y su condición de sujetos de derechos.

2.2. Violencias y salud sexual y reproductiva

Las violencias sexuales mantienen una relación directa y profunda con la salud sexual y reproductiva, en la medida en que afectan el ejercicio libre, informado y autónomo de la sexualidad y la reproducción. Estas violencias no solo constituyen una vulneración grave de los derechos sexuales y reproductivos, sino que también generan riesgos y consecuencias que comprometen de manera significativa el bienestar físico, mental y social de las personas.

Desde el sector salud, esta relación exige un abordaje integral que reconozca las violencias sexuales como un determinante negativo de la salud y como una prioridad en la atención sanitaria. La salud sexual y reproductiva se concibe como un estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y no únicamente como la ausencia de enfermedad.

Este enfoque, desarrollado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y adoptado por el Estado colombiano, reconoce el derecho de todas las personas a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su vida sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia.

Las violencias sexuales vulneran de manera directa este derecho, al imponer prácticas sexuales no consentidas o realizadas bajo amenaza, abuso de poder o

manipulación. Estas situaciones generan consecuencias que afectan la salud sexual y reproductiva y requieren atención integral desde el sector salud.

Entre las principales afectaciones en la salud sexual y reproductiva se encuentran las siguientes:

- Embarazos no deseados.
- Complicaciones ginecológicas y obstétricas.
- Afectaciones en la salud mental asociadas a la vivencia traumática.
- Infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

Estas consecuencias fundamentan la obligación del sector salud de garantizar una atención integral que incluya la identificación de riesgos en salud sexual y reproductiva, la orientación diagnóstica inicial, la provisión de anticoncepción de emergencia, la profilaxis posexposición para VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como el seguimiento clínico oportuno, de conformidad con los protocolos y guías vigentes.

2.3. Tipologías de las violencias sexuales

Las violencias sexuales se manifiestan a través de múltiples tipologías, las cuales presentan características particulares en función del contexto, la relación entre la víctima y el agresor, y las condiciones sociales en las que ocurren. Reconocer estas tipologías es fundamental para orientar una atención integral, diferenciada y adecuada desde el sector salud.

Entre las principales tipologías de violencia sexual se encuentran:

- A. Abuso sexual:** hace referencia a actos sexuales impuestos, generalmente contra niñas, niños y adolescentes, mediante el uso de la fuerza, el engaño,

la manipulación o el abuso de una posición de poder o confianza, sin que necesariamente exista acceso carnal.

- B. Asalto sexual o violación:** comprende el acceso carnal o los actos sexuales forzados mediante violencia física, intimidación o coerción, y puede ocurrir en ámbitos familiares, comunitarios, laborales, educativos o institucionales.
- C. Violencia sexual intrafamiliar:** se presenta cuando los actos de violencia sexual son cometidos por integrantes del núcleo familiar o personas con vínculos cercanos, lo que incrementa el riesgo de cronicidad, silenciamiento y revictimización.
- D. Violencia sexual en la pareja:** incluye cualquier acto sexual no consentido dentro de relaciones de pareja actuales o anteriores, independientemente del estado civil o la convivencia.
- E. Explotación sexual:** consiste en la utilización del cuerpo de una persona, especialmente de niñas, niños y adolescentes, con fines comerciales o de beneficio económico, incluyendo la pornografía y la prostitución forzada.
- F. Trata de personas:** implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante engaño, coerción o abuso de poder, con el propósito de explotación sexual.
- G. Violencia sexual en conflicto armado:** incluye actos de violencia sexual utilizados como estrategia de control, intimidación o dominación sobre comunidades y poblaciones específicas.
- H. Violencia contra diversidad de género:** se manifiesta como una forma de violencia basada en prejuicios, discriminación y estigmatización.

Cada una de estas tipologías exige una respuesta integral y diferenciada por parte del sector salud, considerando las particularidades de la víctima, el contexto del hecho y los riesgos asociados para su salud física y mental.

3. Caracterización epidemiológica de las violencias sexuales

La caracterización epidemiológica de las violencias sexuales permite dimensionar la magnitud del problema, identificar patrones de ocurrencia, reconocer factores de riesgo y orientar la toma de decisiones en salud pública. Desde el sector salud, este análisis constituye un insumo fundamental para la formulación de acciones de prevención, detección temprana, atención integral y seguimiento, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y la normatividad vigente.

3.1. Magnitud y comportamiento de las violencias sexuales

Las violencias sexuales representan un problema prioritario de salud pública debido a su magnitud, persistencia en el tiempo y a las graves consecuencias que generan sobre la salud integral de las personas. Su comportamiento epidemiológico evidencia que no se trata de eventos aislados, sino de fenómenos recurrentes asociados a determinantes sociales, culturales, económicos y estructurales que influyen tanto en su ocurrencia como en las posibilidades de acceso oportuno a los servicios de salud.

El análisis epidemiológico de las violencias sexuales evidencia una ocurrencia sostenida a lo largo del tiempo, con variaciones relacionadas con factores territoriales, contextuales y poblacionales. Entre los principales determinantes asociados se identifican:

- Desigualdades de género y relaciones de poder asimétricas.
- Violencia intrafamiliar y entornos de alta conflictividad.
- Exclusión social y barreras de acceso a servicios de salud.

- Normalización social de la violencia sexual.
- Contextos de violencia sociopolítica, en determinados territorios.

Estos factores influyen tanto en la ocurrencia de las violencias sexuales como en la posibilidad de detección, atención oportuna y notificación de los casos.

Un elemento central en la caracterización epidemiológica de las violencias sexuales es el subregistro, ampliamente reconocido por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Este fenómeno se asocia, entre otros, a los siguientes factores:

- Miedo a represalias por parte de la persona agresora.
- Estigmatización social y cultural de las víctimas.
- Dependencia emocional o económica.
- Normalización o minimización de la violencia.
- Dificultades de acceso a los servicios de salud.

Como consecuencia, una proporción significativa de los casos no ingresa de manera oportuna al sistema de vigilancia, lo que limita la estimación real de la magnitud del problema y afecta la planificación de las acciones en salud pública.

El análisis de la magnitud y el comportamiento de las violencias sexuales permite:

- Identificar patrones de ocurrencia y contextos de mayor riesgo.
- Reconocer brechas en la respuesta institucional.
- Orientar estrategias de prevención y detección temprana.
- Fortalecer las capacidades del talento humano en salud.
- Mejorar la calidad y oportunidad de la atención integral.

En este sentido, la caracterización epidemiológica no cumple únicamente una función descriptiva, sino que constituye una herramienta clave para la toma de decisiones en salud pública, la asignación de recursos y la implementación de acciones integrales orientadas a la reducción del impacto de las violencias sexuales sobre la salud de las personas y las comunidades, en concordancia con la normatividad vigente.

3.2. Violencias sexuales como evento de interés en salud pública

Las violencias sexuales han sido clasificadas en Colombia como eventos de interés en salud pública, lo que implica su vigilancia sistemática, notificación obligatoria y análisis continuo por parte del sector salud. Esta clasificación reconoce el impacto significativo de estas violencias sobre la salud individual y colectiva y la necesidad de orientar acciones de prevención, atención integral y seguimiento desde un enfoque de salud pública.

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), coordinado por el Instituto Nacional de Salud, establece los lineamientos técnicos para la notificación, recolección, análisis y uso de la información relacionada con los eventos de interés en salud pública, entre los cuales se incluyen las violencias sexuales. En este marco, los prestadores de servicios de salud y el talento humano tienen la responsabilidad de identificar y notificar los casos que ingresan a los servicios, como parte de sus funciones en vigilancia epidemiológica.

La notificación de los casos de violencia sexual tiene como propósito principal generar información oportuna y confiable que permita:

- Identificar patrones de ocurrencia y tendencias en el tiempo.
- Reconocer contextos de mayor riesgo y poblaciones priorizadas.

- Detectar brechas en el acceso y la calidad de la atención en salud.
- Orientar la toma de decisiones en salud pública.
- Fortalecer las acciones de prevención, intervención y seguimiento.

Esta información no tiene carácter sancionatorio, sino que cumple una función preventiva, analítica y de gestión, orientada al fortalecimiento de la respuesta institucional en salud. A continuación, se presenta el proceso articulado que guía la notificación y el seguimiento de los casos de violencia sexual.

- Identificación del caso
- Atención integral
- Notificación Savigila
- Análisis epidemiológico
- Acciones de prevención y mejora

La obligación de notificar los casos de violencia sexual se enmarca en los principios establecidos en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental y asigna al Estado y a los actores del sistema responsabilidades en materia de vigilancia, prevención y control de los eventos que afectan la salud de la población. Esta obligación se articula con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral de las personas víctimas de violencias sexuales, los cuales reconocen la vigilancia epidemiológica como un componente esencial del abordaje integral.

3.3. Distribución de las violencias sexuales según contexto de ocurrencia

La distribución de las violencias sexuales según los contextos de ocurrencia es un elemento fundamental para comprender este fenómeno desde la perspectiva de la

salud pública y orientar de manera adecuada las acciones de detección, atención integral y prevención. El análisis por contextos permite identificar escenarios de mayor riesgo, reconocer barreras de acceso a los servicios de salud y definir intervenciones pertinentes, en coherencia con los lineamientos vigentes de vigilancia epidemiológica y atención integral.

Las violencias sexuales pueden presentarse en diversos contextos, cada uno con características particulares que requieren respuestas diferenciadas por parte del sector salud:

- **Contexto familiar y de convivencia**

- Asociado frecuentemente a relaciones de poder, dependencia emocional o económica y dinámicas de control.
- Dificulta la revelación de los hechos y el acceso oportuno a los servicios de salud.
- La normativa colombiana lo reconoce como un ámbito de especial riesgo y establece la obligación de garantizar atención inmediata, confidencial, sin juicios y con activación de rutas de protección, conforme a la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1098 de 2006 en casos de niños, niñas y adolescentes.

- **Contextos comunitarios, educativos, laborales e institucionales**

- Pueden involucrar personas conocidas o desconocidas.
- Se relacionan con abuso de autoridad, jerarquías, relaciones de subordinación y debilidades en los mecanismos de prevención y denuncia.
- La atención en salud debe garantizar integralidad, orientación en derechos y articulación intersectorial, bajo los principios de igualdad, dignidad y no

discriminación establecidos en la Constitución Política y la normativa sectorial.

- **Espacios públicos y privados**

- Se presentan con mayor frecuencia en contextos de inseguridad, consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas y debilidades en los entornos de protección.
- La respuesta del sector salud debe priorizar la valoración clínica integral, la atención de urgencias cuando corresponda y la aplicación estricta de los protocolos vigentes del Ministerio de Salud y Protección Social.

- **Contextos de conflicto armado y violencia sociopolítica**

- La violencia sexual ha sido reconocida como una práctica utilizada para generar control, intimidación y sometimiento de la población.
- Constituye una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
- El sector salud debe garantizar atención integral con enfoque diferencial y articular su actuación con las rutas establecidas para la atención a víctimas del conflicto armado.

La identificación de los contextos de ocurrencia no tiene como propósito clasificar ni jerarquizar a las personas víctimas, sino orientar la respuesta institucional, fortalecer la capacidad del sector salud y mejorar la calidad, pertinencia y oportunidad de la atención. Este análisis contribuye, además, a la formulación de acciones de prevención y al fortalecimiento de los procesos de atención, en coherencia con los principios de la salud pública y la normatividad vigente.

3.4. Factores de riesgo asociados a las violencias sexuales

La identificación de los factores de riesgo asociados a las violencias sexuales es un componente esencial para el abordaje desde la salud pública, ya que permite reconocer las condiciones que incrementan la vulnerabilidad de las personas y los contextos en los que estas violencias ocurren con mayor frecuencia. Este análisis no busca explicar ni justificar la violencia, sino orientar las acciones de promoción de la salud, prevención, detección temprana y atención integral, fortaleciendo la respuesta institucional del sector salud en coherencia con el enfoque de derechos humanos, de género y diferencial.

El siguiente recurso organiza los factores de riesgo asociados a las violencias sexuales en niveles estructurales, familiares, individuales y contextuales, lo que permite analizar cómo interactúan en la generación de vulnerabilidades.

- **S – Factores estructurales (Sociales)**
 - Desigualdades de género
 - Relaciones de poder asimétricas
 - Discriminación y exclusión social
 - Condiciones de pobreza
 - Normalización de la violencia
- **M – Factores familiares y relacionales (Microsociales)**
 - Violencia intrafamiliar
 - Dependencia emocional o económica
 - Antecedentes de maltrato
 - Consumo problemático de alcohol u otras SPA
 - Ausencia de redes de apoyo

- **A – Factores individuales (Atención diferencial)**
 - Edad (niñez, adolescencia, adultez mayor)
 - Discapacidad
 - Dependencia para el cuidado
 - Aislamiento social
 - Crisis emocional o psicológica
- **R–T – Factores contextuales y ambientales (Riesgo territorial)**
 - Inseguridad en espacios públicos y privados
 - Falta de entornos protectores
 - Presencia de economías ilegales
 - Conflicto armado y violencia sociopolítica
 - Debilidad institucional en prevención y control

3.5. Subregistro y barreras de acceso a los servicios de salud

El subregistro de las violencias sexuales constituye una de las principales limitaciones para dimensionar la magnitud real del fenómeno y orientar de manera efectiva las acciones de prevención, detección, atención integral y seguimiento desde la salud pública. Una proporción significativa de los casos no accede oportunamente a los servicios de salud ni es incorporada a los sistemas de vigilancia, lo que debilita la respuesta institucional y la protección de los derechos de las personas víctimas.

Este fenómeno está asociado a múltiples factores individuales, sociales e institucionales que es fundamental reconocer para fortalecer la respuesta del sector salud. A continuación, se presentan los principales:

El subregistro está asociado a múltiples factores individuales, familiares, sociales e institucionales, entre los cuales se destacan:

- **Factores personales y sociales**

- Miedo a represalias por parte de la persona agresora.
- Vergüenza, culpa o estigmatización social.
- Normalización de la violencia sexual en ciertos entornos.
- Dependencia emocional o económica frente al agresor.
- Aislamiento social o ausencia de redes de apoyo.

- **Percepciones y experiencias frente a la atención institucional**

- Desconfianza en los servicios de salud y en otras instituciones.
- Experiencias previas de trato inadecuado o revictimizante.
- Temor a la exposición de la información personal.
- Creencia de que la atención está condicionada a la denuncia.

Las barreras de acceso a los servicios de salud constituyen otro factor determinante del subregistro y pueden presentarse en diferentes niveles:

- **Barreras geográficas y económicas**

- Lejanía de los servicios de salud.
- Dificultades de transporte o costos asociados al desplazamiento.

- **Barreras administrativas e institucionales**

- Trámites innecesarios o dilaciones en la atención.
- Exigencia indebida de requisitos previos.
- Falta de disponibilidad de personal capacitado.
- Horarios de atención limitados o inadecuados.

- **Barreras culturales y comunicativas**

- Falta de información clara sobre los derechos en salud.
- Ausencia de enfoque diferencial según edad, género, discapacidad o contexto.
- Lenguaje técnico o poco comprensible para las personas usuarias.

El subregistro también se relaciona con dificultades en los procesos internos del sector salud, tales como:

- Limitaciones en la identificación temprana de signos de alerta.
- Desconocimiento de los procedimientos de notificación.
- Percepción errónea de la vigilancia en salud pública como un mecanismo sancionatorio.
- Falta de articulación entre los servicios de atención y los sistemas de información.

La superación del subregistro y de las barreras de acceso requiere una respuesta integral del sector salud, orientada a:

- Fortalecer las capacidades del talento humano en detección y atención.
- Garantizar una atención humanizada, confidencial y libre de juicios.
- Mejorar la oportunidad y calidad de la atención.
- Promover la confianza en los servicios de salud.
- Fortalecer la vigilancia en salud pública como herramienta de protección y prevención.

El abordaje del subregistro y de las barreras de acceso es un componente esencial de la respuesta institucional frente a las violencias sexuales, ya que contribuye

a mejorar la atención integral, fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar el restablecimiento de derechos de las personas víctimas.

4. Marco normativo de la atención integral

El marco normativo que regula la atención integral en salud de las personas víctimas de violencias sexuales establece las obligaciones del Estado, las responsabilidades del sector salud y los derechos de las personas afectadas. Este conjunto de disposiciones orienta la actuación del talento humano en salud y garantiza que la atención se brinde con criterios de oportunidad, integralidad, dignidad, confidencialidad y enfoque de derechos, en coherencia con los estándares nacionales e internacionales vigentes.

4.1 Instrumentos internacionales aplicables

La atención integral en la salud a las personas víctimas de violencias sexuales se fundamenta en un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen estas violencias como graves vulneraciones de derechos y establecen obligaciones claras para los Estados en materia de prevención, atención, protección y reparación. Estos instrumentos constituyen referentes esenciales para la formulación de políticas públicas y la organización de los servicios de salud.

De manera general, los instrumentos internacionales reconocen que las violencias sexuales afectan de forma directa derechos fundamentales, entre ellos:

- El derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal.
- El derecho a la dignidad humana y a la integridad física, psicológica y sexual.
- El derecho a la salud física y mental.
- El derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Estos principios se encuentran consagrados en instrumentos de alcance universal, tales como:

- **Declaración Universal de Derechos Humanos**

- Reconoce la dignidad inherente a todas las personas y el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal.
- Constituye el fundamento ético y jurídico del sistema internacional de derechos humanos.

- **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

- Establece obligaciones estatales para la protección de la integridad personal y la libertad.
- Prohíbe tratos crueles, inhumanos o degradantes, directamente relacionados con las violencias sexuales.

- **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

- Reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
- Obliga a los Estados a garantizar el acceso a servicios de salud sin discriminación.

De manera específica, algunos instrumentos abordan de forma directa la violencia sexual y sus impactos diferenciados:

- **Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)**

- Reconoce la violencia sexual como una forma de discriminación contra las mujeres.

- Exige la adopción de medidas integrales para prevenir la violencia y garantizar servicios de atención, protección y recuperación.
- **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)**
 - Reconoce explícitamente la violencia sexual como una violación a los derechos humanos.
 - Establece el deber de actuar con debida diligencia en la prevención, atención y erradicación de la violencia.
- **Convención sobre los Derechos del Niño**
 - Obliga a proteger a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso y explotación sexual.
 - Establece la garantía de atención integral orientada a la recuperación física, psicológica y social.

Como complemento técnico, los organismos internacionales del sistema de salud han desarrollado lineamientos que fortalecen la respuesta de los servicios de salud:

- **Directrices y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)**
 - Reconocen la violencia sexual como un problema de salud pública.
 - Orientan la prestación de servicios integrales, centrados en la persona, basados en evidencia científica y con enfoque de derechos.

En conjunto, estos instrumentos internacionales conforman un marco de referencia que orienta la actuación del sector salud frente a las violencias sexuales. Este marco reconoce que la atención integral no es una acción opcional, sino una obligación derivada de compromisos internacionales en derechos humanos, y establece las bases para garantizar servicios de salud accesibles, oportunos, integrales y libres de

discriminación. Asimismo, constituye el soporte conceptual para el desarrollo de la normativa y los protocolos nacionales aplicables a la atención integral en salud de las personas víctimas de violencias sexuales.

Para profundizar en la normatividad internacional aplicable, se recomienda consultar:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- Convención sobre los Derechos del Niño.

4.2 Normativa nacional sobre violencias sexuales

La normativa nacional colombiana establece un marco jurídico claro para la prevención, atención integral, protección y restablecimiento de derechos de las personas víctimas de violencias sexuales. Este marco define las obligaciones del Estado y, de manera específica, del sector salud, y orienta la actuación del talento humano en coherencia con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el país.

La Constitución Política de Colombia reconoce derechos fundamentales directamente afectados por las violencias sexuales, los cuales orientan la actuación del sector salud:

- Dignidad humana como principio fundante del Estado social de derecho.
- Derecho a la vida (artículo 11).
- Derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículo 13).
- Derecho a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16).
- Derecho a la salud como servicio público esencial y derecho fundamental (artículos 48 y 49).

Estos mandatos constitucionales obligan a garantizar una atención integral, oportuna y sin discriminación a las personas víctimas de violencias sexuales.

En el ámbito penal, el ordenamiento jurídico colombiano reconoce las violencias sexuales como conductas graves:

- El Código Penal (Ley 599 de 2000) tipifica los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.

Incluye conductas como:

- Acceso carnal violento.
- Actos sexuales violentos.
- Abuso sexual.
- Explotación sexual y otras formas de violencia sexual.

Aunque la tipificación penal no regula la atención en salud, sí establece el reconocimiento jurídico de estas violencias y refuerza la obligación institucional de atender integralmente a las víctimas.

Normas específicas de protección y atención

En el ámbito nacional, el marco jurídico colombiano establece disposiciones orientadas a la protección y atención integral de las personas víctimas de violencias sexuales, de acuerdo con la población y el tipo de violencia involucrada:

- **Ley 1146 de 2007**

- Orientada a la prevención de la violencia sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes.
- Asigna responsabilidades al sector salud, entre ellas:
 - Atención médica integral y de urgencias.
 - Garantía de confidencialidad.
 - Prohibición de condicionar la atención a la denuncia previa.

- **Ley 1257 de 2008**

- Desarrolla medidas de sensibilización, prevención y sanción de las violencias contra las mujeres.
- Reconoce la violencia sexual como una forma de violencia basada en género.
- Obliga al sector salud a garantizar:
 - Atención integral y humanizada.
 - Enfoque de derechos humanos y diferencial.
 - Prevención de la revictimización.

- **Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia**

- Reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos prevalentes.

- Establece la obligación de protección integral frente a toda forma de violencia sexual.
- Asigna al sector salud un rol prioritario en:
 - Detección temprana.
 - Atención integral.
 - Articulación con las autoridades para el restablecimiento de derechos.

Derecho fundamental a la salud

En materia de salud, la normativa refuerza el carácter obligatorio de la atención:

- **Ley Estatutaria 1751 de 2015**

- Reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable.
- Establece la obligación de eliminar barreras de acceso a los servicios de salud.
- Exige que la atención en casos de violencia sexual sea:
 - Inmediata.
 - Continua.
 - Libre de condicionamientos administrativos, económicos o judiciales.

Para profundizar en la normatividad internacional aplicable, se recomienda consultar:

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 599 de 2000 – Código Penal Colombiano.
- Ley 1146 de 2007 – Medidas de prevención y atención integral de la violencia sexual, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

- Ley 1257 de 2008 – Medidas de sensibilización, prevención y sanción de las violencias contra las mujeres.
- Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia.

4.3 Normativa del sector salud aplicable a la atención integral

La atención integral en salud a las personas víctimas de violencias sexuales se rige por normas, lineamientos y disposiciones técnicas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales desarrollan los mandatos constitucionales y legales y orientan de manera específica la actuación de los prestadores de servicios de salud y del talento humano.

Entre los principales referentes normativos y técnicos del sector salud se destacan:

A. Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual

- Define los principios, componentes y procesos que orientan la atención desde el sector salud.
- Establece que la atención debe ser:
 - Integral, oportuna y continua.
 - Humanizada y centrada en la persona.
 - Con abordaje en salud física, mental y psicosocial.
- Promueve la articulación con las rutas intersectoriales de protección y justicia.

B. Resolución 459 de 2012

- Adopta el protocolo y el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.

- Establece lineamientos técnicos para:
 - Atención inicial y valoración clínica integral.
 - Atención en salud mental.
 - Profilaxis postexposición.
 - Orientación diagnóstica y seguimiento.
- Señala de manera expresa que la atención en salud:
 - No puede condicionarse a la denuncia previa.
 - Debe aplicarse de forma inmediata y sin barreras.

C. Atención en salud y atención de urgencias

- La normativa del sector salud establece que la atención debe ser:
 - Inmediata y prioritaria.
 - Libre de barreras administrativas.
- Incluye:
 - Evaluación del estado general y del riesgo vital.
 - Atención de lesiones físicas.
 - Prevención de complicaciones posteriores.

D. Atención en salud mental

- Constituye un componente obligatorio del abordaje integral.
- Establece:
 - Valoración del estado mental de toda persona víctima.
 - Acceso a intervenciones psicosociales oportunas.
 - Adecuación de la atención al contexto y necesidades de la persona.
- Busca prevenir afectaciones a largo plazo y reducir el riesgo de revictimización.

E. Vigilancia en salud pública

- Los lineamientos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) establecen:
 - La obligatoriedad de la notificación de los casos atendidos.
 - El uso de la información con fines epidemiológicos y de gestión en salud pública.
- La notificación debe realizarse garantizando:
 - Confidencialidad.
 - Protección de los derechos de las personas víctimas.

F. Consentimiento informado y confidencialidad

- La normativa sectorial exige:
 - Consentimiento libre e informado para los procedimientos, salvo excepciones legales.
 - Manejo ético de la información clínica y médico-legal.
 - Protección de la privacidad y los datos personales.

G. Prevención de la revictimización institucional

- La atención debe:
 - Evitar interrogatorios innecesarios o repetitivos.
 - Garantizar privacidad y trato respetuoso.
 - Brindar información clara sobre procedimientos, derechos y opciones.
- Este enfoque se fundamenta en:
 - La dignidad humana.
 - El enfoque de derechos.
 - La atención centrada en la persona.

En conjunto, la normativa del sector salud configura un marco técnico y operativo que define estándares mínimos de calidad, oportunidad y humanización en la atención integral de las personas víctimas de violencias sexuales. El cumplimiento de estas disposiciones constituye una obligación legal y ética para los prestadores de servicios de salud y el talento humano involucrado en la atención.

4.4 Derechos de las víctimas de violencias sexuales en el sector salud

Las personas víctimas de violencias sexuales son titulares de derechos específicos en el ámbito del sector salud, derivados de la Constitución Política, la normativa nacional vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. Estos derechos orientan la prestación de los servicios de salud y constituyen obligaciones de cumplimiento obligatorio para los prestadores y el talento humano en salud.

Entre los principales derechos se destacan:

- a.** Derecho a la atención integral, oportuna y sin barreras.
- b.** Derecho a una atención digna, humanizada y sin discriminación.
- c.** Derecho a la información clara y comprensible.
- d.** Derecho al consentimiento informado.
- e.** Derecho a la confidencialidad y reserva de la información.
- f.** Derecho a la atención en salud mental y apoyo psicosocial.
- g.** Derecho a la articulación intersectorial.
- h.** Derecho a la no revictimización.

Estos derechos deben garantizarse de manera transversal en todos los momentos de la atención en salud, desde el primer contacto con los servicios hasta el seguimiento

posterior, y no pueden entenderse como acciones aisladas. Su reconocimiento y aplicación efectiva orientan la actuación del talento humano y de los prestadores de servicios de salud, fortalecen la confianza de las personas víctimas en el sistema sanitario y contribuyen a una atención integral, digna y libre de revictimización.

4.5 Responsabilidades del talento humano en salud

El talento humano en salud asume responsabilidades éticas, técnicas y legales en la atención integral de las personas víctimas de violencias sexuales. Estas responsabilidades se fundamentan en el marco constitucional, la normativa vigente y los lineamientos técnicos del sector salud, y orientan la actuación profesional hacia la garantía de una atención integral, oportuna, digna y respetuosa de los derechos humanos.

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

a. Garantizar la atención inmediata e integral

- Asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos.
- Evitar barreras administrativas, económicas o judiciales.
- No condicionar la atención a la afiliación al sistema ni a la denuncia previa.
- Priorizar la protección de la vida, la integridad y la salud de la persona víctima.

b. Realizar la valoración clínica integral

- Evaluar el estado general de salud.
- Identificar lesiones físicas y riesgos asociados.
- Valorar el estado mental y emocional.

- Actuar conforme a los lineamientos del modelo y los protocolos vigentes del sector salud.

c. Garantizar el consentimiento informado

- Brindar información clara, suficiente y comprensible sobre los procedimientos.
- Respetar la autonomía y las decisiones de la persona.
- Obtener y documentar la autorización libre y voluntaria para las intervenciones.
- Actuar de acuerdo con los principios éticos y legales aplicables.

d. Proteger la confidencialidad y la información clínica

- Garantizar la reserva de la historia clínica y de los datos personales.
- Compartir información únicamente en los casos autorizados por la ley.
- Aplicar un manejo ético y responsable de la información.

e. Prevenir la revictimización institucional

- Evitar interrogatorios innecesarios o repetitivos.
- Abstenerse de emitir juicios de valor o actitudes culpabilizantes.
- Garantizar un trato respetuoso, empático y digno durante toda la atención.

f. Cumplir con la vigilancia en salud pública

- Realizar la notificación obligatoria de los casos de violencia sexual.
- Seguir los protocolos establecidos para la vigilancia epidemiológica.
- Garantizar la confidencialidad y el respeto por los derechos de la persona atendida.

g. Articular con otros sectores cuando corresponda

- Facilitar el acceso a rutas de protección, justicia y apoyo social.

- Respetar la voluntad y las decisiones informadas de la persona víctima.
- Actuar de manera obligatoria en los casos que involucren niños, niñas y adolescentes.

h. Actualizar permanentemente sus competencias

- Fortalecer conocimientos técnicos y normativos.
- Incorporar enfoques de derechos humanos, género y diferencial.
- Garantizar una atención basada en la evidencia y en estándares de calidad.

El cumplimiento de estas responsabilidades permite que la atención en salud a las personas víctimas de violencias sexuales se realice de manera coherente con el marco normativo y los principios éticos del ejercicio profesional, contribuyendo a la protección de la salud integral y al restablecimiento de derechos.

El cumplimiento de estas responsabilidades asegura que la atención en salud a las personas víctimas de violencias sexuales se desarrolle en coherencia con el marco normativo vigente, los estándares técnicos del sector salud y los principios éticos que rigen el ejercicio profesional, contribuyendo de manera efectiva a la protección de la salud integral y al restablecimiento de derechos.

5. Enfoques para la atención integral frente a la violencia sexual

El abordaje integral de las violencias sexuales desde el sector salud exige la aplicación de enfoques que orienten la atención más allá de la intervención clínica inmediata, permitiendo responder de manera adecuada a la complejidad del fenómeno y a las necesidades específicas de las personas víctimas. Estos enfoques se encuentran reconocidos en la normativa vigente, en los modelos y lineamientos del sector salud y en los compromisos internacionales del Estado colombiano, y constituyen criterios obligatorios para la prestación de servicios de salud.

5.1 Enfoque de derechos humanos

El enfoque de derechos humanos constituye el eje central del abordaje integral de las violencias sexuales y orienta la actuación del sector salud hacia la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de las personas víctimas. Este enfoque reconoce a las personas como sujetos de derechos y no únicamente como receptoras de servicios, y exige que la atención se brinde con base en los principios de dignidad humana, igualdad, autonomía, participación y no discriminación.

En el contexto colombiano, este enfoque se fundamenta en la Constitución Política y se desarrolla a través de la normativa vigente que regula la atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales. Dicho marco establece que la atención debe ser integral, oportuna, confidencial y libre de barreras, y que no puede condicionarse a la denuncia previa de los hechos.

La aplicación del enfoque de derechos humanos en la atención en salud implica:

- Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud requeridos.

- Respetar la autonomía y las decisiones informadas de la persona víctima.
- Asegurar el consentimiento informado para los procedimientos clínicos y médico-legales.
- Proteger la confidencialidad y la reserva de la información.
- Prevenir cualquier forma de revictimización institucional.
- Adoptar prácticas de atención respetuosas, dignas y humanizadas.

Desde este enfoque, el sector salud debe articular su actuación con otros sectores responsables de la protección y el restablecimiento de derechos, facilitando el acceso a las rutas correspondientes y respetando en todo momento la voluntad y las decisiones de la persona víctima. El enfoque de derechos humanos, por tanto, orienta de manera transversal la respuesta institucional frente a las violencias sexuales y constituye un criterio esencial de calidad en la atención integral en salud.

5.2 Enfoque de género

El enfoque de género permite comprender las violencias sexuales como fenómenos vinculados a relaciones de poder desiguales y a construcciones sociales que reproducen la discriminación y la subordinación, especialmente contra las mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad. Este enfoque reconoce que las violencias sexuales no afectan a todas las personas de la misma manera y que dichas diferencias deben ser consideradas de forma explícita en la atención en salud.

Desde este enfoque, se reconoce que las violencias sexuales:

- Están relacionadas con desigualdades históricas de género.
- Se ven reforzadas por estereotipos y normas sociales que naturalizan la violencia.

- Generan impactos diferenciados en la salud física, mental y emocional de las personas víctimas.

En el contexto colombiano, la normativa vigente reconoce la violencia sexual como una violación a los derechos humanos y una manifestación de las desigualdades de género, y asigna al sector salud la obligación de garantizar una atención integral con enfoque de género. Este enfoque exige:

- a) Identificar y cuestionar estereotipos de género presentes en la atención.
- b) Evitar prácticas discriminatorias o revictimizantes.
- c) Reconocer las experiencias y necesidades específicas de las personas víctimas.

En la atención en salud, la aplicación del enfoque de género implica:

- Garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
- Brindar una atención libre de juicios morales y estigmatización.
- Reconocer los impactos diferenciados de la violencia sexual en mujeres, hombres y personas con identidades de género diversas.
- Fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión de las personas atendidas.
- Adoptar medidas orientadas a prevenir la revictimización institucional.

El enfoque de género, articulado con el enfoque de derechos humanos, orienta una atención en salud más equitativa, sensible y pertinente, y constituye un criterio esencial para responder de manera integral a las violencias sexuales desde el sector salud.

5.3 Enfoque diferencial y de ciclo vital

El enfoque diferencial reconoce que las personas víctimas de violencias sexuales no son un grupo homogéneo y que factores como la edad, la discapacidad, la pertenencia étnica, la orientación sexual, la identidad de género y las condiciones socioeconómicas influyen en la forma en que se vive la violencia y en las necesidades de atención. Este enfoque se encuentra respaldado por la Constitución Política y desarrollado en normas como la Ley 1098 de 2006, la Ley 1618 de 2013 y otros instrumentos de protección de poblaciones con especial protección constitucional.

El enfoque de ciclo vital, como parte del enfoque diferencial, exige que la atención en salud se adecúe a las características y necesidades propias de cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la vejez. En el caso de niños, niñas y adolescentes, este enfoque implica la adopción de medidas reforzadas de protección, la articulación con los procesos de restablecimiento de derechos y el respeto por el interés superior del niño, conforme a la normativa vigente.

La aplicación del enfoque diferencial y de ciclo vital permite al sector salud brindar una atención más pertinente, efectiva y respetuosa, y constituye un criterio obligatorio en la atención integral de las violencias sexuales.

5.4 Enfoque psicosocial

El enfoque psicosocial reconoce que las violencias sexuales generan impactos que trascienden lo físico y afectan profundamente la salud mental, las relaciones sociales y el proyecto de vida de las personas. Este enfoque orienta la atención en salud hacia la comprensión integral de las afectaciones emocionales, psicológicas y sociales, y hacia la

implementación de intervenciones que contribuyan a la recuperación y al fortalecimiento de capacidades de afrontamiento.

Los lineamientos del sector salud establecen que la atención psicosocial debe ser un componente obligatorio del abordaje integral de las violencias sexuales, e incluir la valoración del estado mental, la identificación de riesgos psicosociales y el acceso a intervenciones oportunas y adecuadas. Este enfoque también exige reconocer la influencia del entorno familiar y social en el proceso de recuperación y promover la articulación con redes de apoyo cuando sea pertinente.

5.5 Prevención de la revictimización

La prevención de la revictimización constituye un enfoque transversal en la atención integral de las violencias sexuales y orienta todas las actuaciones del sector salud. La revictimización se presenta cuando las prácticas institucionales reproducen o profundizan el daño sufrido por la persona víctima, afectando su dignidad, su confianza en los servicios y su proceso de recuperación.

La revictimización puede manifestarse a través de:

- Barreras injustificadas para el acceso oportuno a los servicios de salud.
- Trato irrespetuoso, descalificador o carente de empatía.
- Emisión de juicios de valor o actitudes culpabilizantes.
- Exposición indebida de la información personal o clínica.
- Interrogatorios innecesarios o repetitivos.

La normativa vigente y los lineamientos técnicos del sector salud establecen la obligación de adoptar medidas orientadas a prevenir la revictimización, garantizando

una atención digna, confidencial y centrada en la persona. En este sentido, el talento humano en salud debe actuar con sensibilidad, respeto y profesionalismo, y revisar de manera permanente sus prácticas para asegurar una atención humanizada, ética y de calidad.

La prevención de la revictimización implica:

- Garantizar la privacidad durante la atención.
- Evitar la repetición innecesaria del relato de los hechos.
- Brindar información clara y suficiente sobre los procedimientos.
- Respetar la autonomía y las decisiones informadas de la persona.
- Adoptar un trato empático y libre de discriminación.

Este enfoque contribuye a fortalecer la confianza en los servicios de salud, a mejorar la calidad de la atención y a proteger de manera efectiva los derechos de las personas víctimas de violencias sexuales.

6. Proceso de atención integral en salud

La atención integral en salud frente a las violencias sexuales comprende un conjunto de acciones articuladas, secuenciales y obligatorias que deben implementarse desde el primer contacto con la persona afectada. Estas acciones se fundamentan en los principios de dignidad, enfoque de derechos humanos, confidencialidad, oportunidad y no revictimización, conforme a la normativa vigente y a los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social.

La atención no se limita a la respuesta inmediata en urgencias ni a la resolución de las consecuencias físicas iniciales. Por el contrario, implica un abordaje integral que incluye las siguientes etapas:

- a) Recepción y primer contacto con enfoque humanizado.
- b) Valoración clínica integral del estado general de salud.
- c) Identificación y atención de lesiones físicas.
- d) Valoración del estado mental y emocional.
- e) Orientación diagnóstica inicial.
- f) Implementación de medidas preventivas y terapéuticas.
- g) Atención en salud mental y apoyo psicosocial.
- h) Articulación con las rutas de atención, protección y justicia.
- i) Seguimiento y continuidad de la atención.

Este proceso responde a los estándares definidos en el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual y en los lineamientos técnicos del sector salud, los cuales establecen los componentes mínimos que deben garantizar los servicios de salud para una atención integral, oportuna y sin revictimización.

6.1 Principios del proceso de atención integral

El proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales se rige por un conjunto de principios que orientan la actuación del talento humano y garantizan una respuesta ética, técnica y legalmente adecuada. Estos principios son de obligatorio cumplimiento y se derivan del marco constitucional, legal y sectorial vigente. Para profundizar en su comprensión, se invita a acceder al siguiente pódcast:

Pódcast: Principios del proceso de atención integral

Nombre del programa: Principios del proceso de atención integral

Personajes: hombre, mujer.

Mujer: brindar atención a una persona víctima de violencia sexual implica mucho más que aplicar un procedimiento.

Hombre: requiere actuar con principios claros que orienten cada momento de la atención.

Mujer: porque no se trata solo de intervenir, sino de garantizar una atención digna, segura y centrada en la persona.

Hombre: en este episodio conoceremos los principios que orientan el proceso de atención integral.

Mujer: el primero es la atención inmediata. Brindar ayuda oportuna puede marcar la diferencia en la protección de la salud física y emocional.

Hombre: también está la integralidad, que reconoce que cada persona necesita una atención completa.

Mujer: se requiere una atención que contemple lo físico, lo emocional y lo social, porque todo influye en el bienestar.

Hombre: otro principio fundamental es la dignidad humana. Esto implica reconocer a cada persona como sujeto de derechos, evitando cualquier forma de trato deshumanizante.

Mujer: a esto se suma la confidencialidad, clave para proteger la privacidad y generar confianza.

Hombre: resguardar la información no es solo un deber legal, también es una forma de cuidado.

Mujer: el consentimiento informado es otro pilar dentro del proceso de atención.

Hombre: garantiza que cada decisión se tome con claridad, respeto y participación de la persona atendida.

Mujer: también es fundamental evitar la revictimización. Evitar prácticas que repitan el daño es esencial para una atención verdaderamente humana.

Hombre: y en medio de todo, hay un principio que eleva la calidad de la atención: el enfoque diferencial. Reconocer las particularidades de cada persona permite brindar un acompañamiento más justo e inclusivo.

Mujer: todos estos principios no son conceptos aislados.

Hombre: son la base que orienta cada acción del talento humano en salud.

Mujer: aplicarlos fortalece la confianza, protege los derechos y mejora la calidad del proceso de atención.

Hombre: porque cuando los principios guían la atención, también se protege la dignidad de quienes más lo necesitan.

Mujer: gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio.

En conjunto, estos principios orientan de manera transversal el proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales y constituyen criterios esenciales de calidad, ética y legalidad en la actuación del sector salud y del talento humano involucrado.

6.2 Recepción y atención inicial de la persona víctima

La recepción y atención inicial de la persona víctima de violencias sexuales constituye el primer momento del proceso de atención integral en salud y tiene un impacto determinante en la calidad de la respuesta institucional, la protección de la salud integral y la prevención de la revictimización. Este momento se rige por la normativa vigente y debe desarrollarse conforme a los principios de atención inmediata, dignidad humana, confidencialidad y enfoque de derechos.

La atención inicial debe brindarse:

- De manera inmediata y prioritaria.
- Sin barreras administrativas, económicas o judiciales.
- Independientemente de:
 - El tiempo transcurrido desde el hecho.
 - El régimen de afiliación al sistema de salud.
 - La presentación de denuncia previa.

Ninguna institución prestadora de servicios de salud puede negar o retrasar la atención, dado que se trata de una situación que compromete la integridad física, mental y la dignidad de la persona.

Durante la recepción, el talento humano en salud debe garantizar:

- Un ambiente seguro, privado y confidencial.
- Un trato respetuoso, empático y libre de juicios.
- La prevención de la revictimización, evitando:
 - Interrogatorios innecesarios o repetitivos.
 - Actitudes culpabilizantes.
 - Exposición indebida de la información.

La atención inicial constituye un momento clave del proceso integral, ya que define la calidad de la respuesta institucional y la protección de los derechos de la persona. En este contexto, el talento humano en salud desempeña un papel determinante para garantizar una intervención oportuna, segura y libre de revictimización. A partir de esta responsabilidad, se establecen acciones específicas que deben desarrollarse durante la atención inicial.

Talento humano:

- Identificar de manera oportuna la posible situación de violencia sexual.
- Reconocer que la consulta puede presentarse por:
 - Síntomas físicos inespecíficos.
 - Manifestaciones emocionales o psicológicas.
- Actuar conforme a los protocolos establecidos:
 - Sin forzar el relato de los hechos.

- Respetando la autonomía y el ritmo de la persona.

Acciones inmediatas:

- Brindar información clara y comprensible sobre:
 - Derechos en salud.
 - Servicios disponibles.
 - Etapas del proceso de atención.
- Garantizar el derecho al consentimiento informado.
- Adaptar la información a las condiciones, capacidades y necesidades de la persona.

Atención inicial:

- La clasificación de la urgencia.
- La identificación de riesgos inmediatos para la vida o la salud.
- La definición de la prioridad de atención y de las acciones a seguir.

La atención inicial a personas víctimas de violencias sexuales exige consideraciones específicas según la población atendida y los componentes que garantizan una respuesta oportuna e integral. A continuación, se presentan dos aspectos fundamentales que orientan este proceso:

Atención a niños, niñas y adolescentes

- Aplicar el principio del interés superior del niño.
- Garantizar medidas reforzadas de protección.
- Asegurar la confidencialidad.

- Articular la atención con las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos.
- Evitar cualquier retraso en la atención en salud.

Componentes de la recepción inicial

- La activación temprana de:
 - La valoración clínica integral.
 - La atención en salud mental.
 - Las rutas intersectoriales de protección y justicia.
- La participación informada de la persona en las decisiones relacionadas con su atención.

En este sentido, la recepción y atención inicial no constituye un acto meramente administrativo, sino un componente fundamental del proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales. Su adecuada implementación contribuye de manera decisiva a la protección de la salud integral, al restablecimiento de derechos y a la prevención de daños adicionales derivados de una atención inadecuada o revictimizante.

6.3 Evaluación del estado general y del riesgo vital

Es un componente fundamental del proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales, ya que permite identificar de manera temprana situaciones que comprometen la vida o la estabilidad clínica y orientar de forma adecuada las intervenciones prioritarias. Esta evaluación debe realizarse de manera inmediata, sistemática y conforme a los lineamientos técnicos vigentes del sector salud.

Toda persona víctima de violencia sexual que ingresa a los servicios de salud debe ser evaluada inicialmente para determinar su estado general de salud y la existencia de riesgos vitales, sin que este procedimiento pueda verse retrasado por trámites administrativos u otras actuaciones no urgentes. La prioridad de esta evaluación responde a la necesidad de proteger la vida, la integridad física y la salud mental de la persona.

La valoración del estado general comprende la identificación de signos y síntomas que indiquen compromiso hemodinámico, neurológico o respiratorio, así como la detección de lesiones físicas evidentes o potenciales. Esta evaluación debe realizarse de forma integral, considerando tanto las manifestaciones clínicas visibles como aquellas que pueden no ser evidentes en el primer contacto, en coherencia con los principios de atención integral y de calidad.

La identificación del riesgo vital implica reconocer condiciones que requieren intervención inmediata, tales como:

- Hemorragias activas.
- Traumatismos severos.
- Alteraciones del estado de conciencia.
- Dolor intenso.
- Signos de infección aguda.
- Otras situaciones que comprometan la vida o la estabilidad clínica.

6.4 Valoración clínica integral

Es un componente central del proceso de atención en salud a personas víctimas de violencias sexuales. Su finalidad es identificar de manera sistemática las afectaciones

físicas, mentales y emocionales derivadas del hecho, orientar las decisiones clínicas y garantizar una atención acorde con los lineamientos técnicos y normativos vigentes. Esta valoración debe realizarse una vez asegurada la estabilidad clínica y el control del riesgo vital, bajo criterios de integralidad, dignidad y no revictimización.

La normativa del sector salud establece que la valoración clínica integral debe:

- Centrarse en las necesidades de salud de la persona.
- Evitar la reconstrucción detallada del evento con fines judiciales.
- Prevenir prácticas invasivas innecesarias.
- Evitar la repetición injustificada del relato de los hechos.

La anamnesis debe realizarse de manera:

- Cuidadosa, respetuosa y focalizada.
- Orientada a recoger solo la información necesaria para la atención en salud.
- Respetando:
 - El ritmo de la persona.
 - Su autonomía.
 - Su derecho a no responder determinadas preguntas.

El examen físico se desarrolla en tres momentos fundamentales que orientan al talento humano en la salud hacia una atención clínica ordenada, segura y respetuosa de los derechos de la persona víctima:

- **Realización del examen**
 - De la cabeza a los pies.
 - Con registro fotográfico cuando aplique.
 - Documentando hallazgos en la historia clínica.

- **Identificación de hallazgos**

- Lesiones visibles o no visibles.
- Signos de trauma.
- Infecciones u otras alteraciones relacionadas con la violencia sexual.

- **Principios éticos de la atención**

- Privacidad.
- Confidencialidad.
- Consentimiento informado.

Previo a su realización, se debe explicar a la persona el procedimiento y respetar su decisión de aceptar o rechazar determinadas intervenciones.

Cuando exista indicación clínica, los exámenes genitales y anogenitales deben realizarse bajo criterios de confidencialidad, consentimiento informado y estricto apego a los protocolos vigentes.

- Realizarse únicamente con consentimiento informado expreso.
- Ser practicados por personal capacitado.
- Ajustarse a los protocolos vigentes del sector salud.
- Evitar su uso rutinario o sin justificación clínica.

La valoración del estado mental

Permite identificar afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de la violencia sexual:

- Afectaciones emocionales.
- Síntomas de ansiedad o depresión.
- Manifestaciones de estrés postraumático.

- Ideación suicida u otros riesgos en salud mental.

Esta valoración debe integrarse desde el primer contacto y no limitarse a una intervención posterior, permitiendo la adopción de medidas oportunas de atención y seguimiento.

Identificación de riesgos adicionales

Durante la valoración clínica integral se deben identificar riesgos asociados, tales como:

- Riesgo de embarazo.
- Infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.
- Otras complicaciones derivadas del hecho.

Esta identificación orienta la implementación de medidas preventivas y terapéuticas conforme a los protocolos vigentes.

Registro en la historia clínica

La valoración clínica integral debe documentarse de manera clara y completa en la historia clínica, consignando:

- Hallazgos relevantes.
- Decisiones clínicas adoptadas.
- Intervenciones realizadas.

Este registro es fundamental para garantizar la continuidad de la atención, la calidad del proceso asistencial y el cumplimiento de las responsabilidades técnicas y legales del sector salud.

En conjunto, la valoración clínica integral permite al sector salud comprender de manera completa el impacto de la violencia sexual sobre la salud de la persona y orientar una respuesta adecuada, oportuna y centrada en la protección de la salud integral y de los derechos, en cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares técnicos del sector.

6.5 Procedimientos médicos y medidas terapéuticas complementarias

Los procedimientos médicos y las medidas terapéuticas complementarias hacen parte del proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales y se realizan con el propósito de prevenir complicaciones, tratar las afectaciones identificadas durante la valoración clínica integral y proteger la salud física y mental de la persona. Estas intervenciones deben aplicarse únicamente cuando estén clínicamente indicadas, bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos de la persona víctima.

De conformidad con los lineamientos técnicos del sector salud, los procedimientos médicos deben realizarse una vez asegurada la estabilidad clínica, garantizando en todo momento el consentimiento informado, la privacidad y la confidencialidad. El talento humano en salud debe explicar de manera clara y comprensible el objetivo de cada intervención, sus beneficios, posibles riesgos y alternativas, respetando la decisión de la persona de aceptar o rechazar los procedimientos, salvo las excepciones previstas en la ley.

Entre los principales procedimientos médicos y medidas complementarias se incluyen:

- **Exámenes físicos específicos**

- Realizados únicamente cuando aporten información relevante para la atención en salud.
- Orientados al manejo clínico y no a la reconstrucción judicial de los hechos.
- Aplicados con trato respetuoso y evitando exposiciones innecesarias.

- **Exámenes genitales y anogenitales**

- Indicados solo cuando sean clínicamente necesarios.
- Requieren consentimiento informado expreso.
- Deben ser realizados por personal capacitado.
- No son procedimientos rutinarios ni obligatorios.

- **Pruebas diagnósticas y de laboratorio**

- Pruebas para infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.
- Evaluación de riesgo de embarazo.
- Otros exámenes según los hallazgos clínicos.
- Su indicación debe responder exclusivamente a criterios clínicos.

- **Medidas preventivas y terapéuticas**

- Profilaxis postexposición para infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, cuando esté indicada.
- Anticoncepción de emergencia, de acuerdo con los protocolos vigentes.
- Tratamiento inicial de lesiones físicas o infecciones identificadas.
- Intervenciones orientadas a prevenir complicaciones posteriores.

Estas medidas deben brindarse de manera oportuna y sin barreras, en cumplimiento del derecho fundamental a la salud y de los estándares de atención definidos para la atención integral de las violencias sexuales.

Todos los procedimientos realizados y las medidas adoptadas deben quedar debidamente registrados en la historia clínica, consignando de forma clara las intervenciones efectuadas, las decisiones clínicas tomadas y el consentimiento otorgado por la persona. Este registro es un deber técnico y legal y garantiza la continuidad de la atención y la calidad del proceso asistencial.

En los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, los procedimientos médicos y las medidas terapéuticas complementarias deben aplicarse bajo el principio del interés superior del niño, garantizando medidas de protección reforzada, la participación de personal capacitado y la articulación con las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos, sin que ello implique retrasos en la atención en salud ni vulneración de la dignidad de la persona.

En conjunto, los procedimientos médicos y las medidas terapéuticas complementarias constituyen una fase operativa del proceso de atención integral en salud, orientada a proteger la salud, prevenir daños adicionales y garantizar una respuesta clínica adecuada, ética y acorde con la normativa vigente frente a las violencias sexuales.

6.6 Orientación diagnóstica inicial

Constituye una fase de integración clínica dentro del proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales. Su finalidad es analizar de manera conjunta los hallazgos obtenidos durante la valoración clínica integral y los

procedimientos realizados, con el fin de definir las decisiones clínicas inmediatas y garantizar la continuidad de la atención.

En el contexto de la atención en salud, la orientación diagnóstica tiene un carácter exclusivamente clínico y sanitario. No corresponde a una calificación judicial de los hechos, sino a la identificación de condiciones de salud, riesgos y necesidades de atención que orientan el plan terapéutico y preventivo. El talento humano en salud debe centrar su actuación en el abordaje integral de la persona, evitando emitir juicios o conclusiones con fines legales.

La orientación diagnóstica inicial permite:

- Integrar los hallazgos físicos, mentales y emocionales identificados.
- Definir las intervenciones inmediatas requeridas.
- Establecer la necesidad de seguimiento clínico.
- Determinar la pertinencia de referencia o contrarreferencia a otros servicios o niveles de complejidad.
- Garantizar la continuidad del proceso de atención integral.

Las decisiones adoptadas en esta fase deben comunicarse de manera clara y comprensible a la persona, respetando su autonomía, garantizando el consentimiento informado y la confidencialidad de la información. Asimismo, deben quedar debidamente registradas en la historia clínica, como parte del plan inicial de atención.

En los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, la orientación diagnóstica inicial debe realizarse aplicando el principio del interés superior del niño y articulando las acciones necesarias para el restablecimiento de derechos, sin que ello limite o retrase la atención en salud.

En síntesis, la orientación diagnóstica inicial no constituye una nueva evaluación clínica, sino un momento decisorio que consolida la respuesta sanitaria frente a las violencias sexuales y orienta un plan de atención integral, continuo y centrado en la protección de la salud y los derechos de la persona víctima.

6.7 Seguimiento, referencia y contrarreferencia

Son componentes esenciales del proceso de atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales, ya que permiten garantizar la continuidad del cuidado, dar respuesta a las necesidades identificadas y reducir el riesgo de complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Estas acciones deben desarrollarse conforme a la normativa vigente y a los lineamientos técnicos del sector salud.

El seguimiento en salud tiene como propósito evaluar la evolución clínica, física y mental de la persona, verificar la efectividad de las intervenciones realizadas y detectar oportunamente nuevas necesidades de atención. Este seguimiento debe definirse desde la orientación diagnóstica inicial y ajustarse a los riesgos y condiciones particulares de cada caso, en coherencia con los principios de integralidad y continuidad de la atención.

En el ámbito de la salud mental, el seguimiento adquiere especial relevancia, dado que las afectaciones emocionales y psicológicas asociadas a la violencia sexual pueden manifestarse de manera diferida o persistir en el tiempo. Por ello, el sector salud debe garantizar el acceso a intervenciones psicosociales continuas y, cuando sea necesario, a servicios especializados, de forma oportuna y pertinente.

La referencia corresponde a la remisión de la persona a otro nivel de atención o a un servicio especializado cuando la complejidad del caso o las condiciones clínicas así lo

requieren. Esta decisión debe basarse en criterios técnicos y clínicos, garantizar la continuidad del proceso de atención y brindarse con información clara a la persona, respetando su autonomía y evitando cargas o barreras injustificadas.

La contrarreferencia permite el retorno de la persona al servicio de origen o a un nivel de menor complejidad, una vez se ha proporcionado la atención especializada requerida. Este proceso es fundamental para asegurar la continuidad del cuidado y la adecuada coordinación entre los diferentes niveles del sistema de salud, y debe realizarse con información clínica suficiente y oportuna.

En los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, el seguimiento y los procesos de referencia y contrarreferencia deben aplicarse con especial cuidado, bajo el principio del interés superior del niño, y articularse con las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos, sin retrasar la atención en salud ni vulnerar la confidencialidad.

Todas las acciones de seguimiento, referencia y contrarreferencia deben quedar debidamente registradas en la historia clínica, consignando las decisiones adoptadas y las remisiones realizadas. Este registro garantiza la trazabilidad del proceso de atención y el cumplimiento de las responsabilidades técnicas y legales del sector salud.

En conjunto, estos componentes aseguran que la atención a las personas víctimas de violencias sexuales se desarrolle como un proceso continuo, articulado y centrado en la protección de la salud integral y los derechos de las personas, y no como una intervención aislada o limitada en el tiempo.

7. Articulación intersectorial y rutas de atención

La atención integral en salud a personas víctimas de violencia sexual requiere una respuesta coordinada entre el sector salud y otros sectores del Estado responsables de la protección, la justicia y el restablecimiento de derechos. La articulación intersectorial permite garantizar una atención oportuna, continua y coherente, evitar vacíos institucionales y reducir el riesgo de revictimización.

Este enfoque se fundamenta en el marco normativo colombiano, que reconoce la violencia sexual como un fenómeno complejo que exige la actuación conjunta de múltiples sectores, sin que dicha coordinación condicione o limite la atención en la salud.

7.1 Articulación intersectorial en la atención integral

La articulación intersectorial se entiende como el proceso de coordinación entre el sector salud y otras entidades del Estado, orientado a garantizar la atención integral, la protección y el restablecimiento de los derechos de las personas víctimas de violencias sexuales. Este proceso hace parte de la respuesta institucional y está respaldado por el marco normativo y los lineamientos técnicos vigentes. Desde el sector salud, la articulación intersectorial cumple un papel estratégico, dado que los servicios de salud suelen constituirse en el primer punto de contacto institucional para las personas víctimas.

La articulación intersectorial en la atención integral se desarrolla a través de tres elementos fundamentales que orientan la actuación coordinada del sector salud:

A. En este contexto, la actuación del sector salud se orienta a garantizar una respuesta oportuna, coordinada y centrada en los derechos de la persona víctima:

- Facilitar el acceso oportuno a las rutas de atención integral.
- Brindar orientación clara sobre las opciones institucionales disponibles.
- Coordinar la actuación con otras entidades responsables de la protección y garantía de derechos.
- Evitar que la persona víctima asuma la carga de gestionar su propio proceso institucional.

B. La articulación intersectorial comprende la coordinación con diferentes instancias del Estado que cumplen roles específicos en la protección y el restablecimiento de derechos:

- Fiscalía General de la Nación, para los procesos de investigación penal, cuando la persona decide denunciar.
- Comisarías de familia, en los casos de violencia intrafamiliar o cuando se requieran medidas de protección.
- Defensorías de familia y autoridades administrativas competentes, especialmente en situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.
- Otras entidades del orden nacional o territorial responsables del restablecimiento de derechos y la protección integral.

C. Este proceso de articulación debe desarrollarse garantizando en todo momento condiciones que protejan la dignidad, la autonomía y los derechos de la persona atendida:

- El respeto por la confidencialidad de la información.
- La autonomía y la voluntad informada de la persona víctima.
- La aplicación del enfoque de derechos humanos y diferencial.
- La prevención de cualquier forma de revictimización institucional.

La normativa vigente establece de manera expresa que la atención en salud no puede condicionarse a la activación de las rutas intersectoriales ni a la denuncia de los hechos. En este sentido, la articulación intersectorial debe complementar la atención sanitaria, sin sustituirla ni retrasarla, asegurando una respuesta integral, oportuna y centrada en la persona.

7.2 Consentimiento informado

El consentimiento informado constituye un principio ético y legal fundamental en la atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales. Su aplicación garantiza el respeto por la autonomía, la dignidad y la capacidad de decisión de la persona, especialmente en un contexto en el que estos derechos han sido vulnerados.

En el sector salud, el consentimiento informado se entiende como el proceso mediante el cual la persona recibe información clara, suficiente y comprensible sobre los procedimientos, intervenciones y opciones de atención, y decide libremente si acepta o no su realización. Este proceso debe desarrollarse de manera continua y no limitarse a un acto único o meramente formal.

En la atención a personas víctimas de violencias sexuales, el consentimiento informado implica:

- **Informar de manera clara y comprensible sobre:**
 - Los procedimientos clínicos y médico-legales propuestos.
 - Los beneficios, riesgos y posibles consecuencias de cada intervención.
 - Las alternativas disponibles y el derecho a aceptar o rechazar procedimientos.
- **Garantizar que la decisión se tome:**
 - Sin presión, coerción o intimidación.
 - Respetando el ritmo, las emociones y las condiciones de la persona.
- **Reconocer que el consentimiento:**
 - Puede ser retirado en cualquier momento.
 - No condiciona el acceso a otros servicios de salud.

La normativa del sector salud establece que ningún procedimiento clínico, examen físico, toma de muestras o intervención médico-legal puede realizarse sin el consentimiento libre e informado de la persona, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. Esta obligación adquiere especial relevancia en procedimientos invasivos, como los exámenes genitales o anogenitales, los cuales solo deben realizarse cuando estén clínicamente indicados y con consentimiento expreso.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, el consentimiento informado debe aplicarse conforme a su edad, grado de madurez y capacidad de comprensión, garantizando su derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones relacionadas con su atención. Adicionalmente, debe obtenerse la autorización de los representantes

legales, sin que ello implique desconocer la voluntad del niño, niña o adolescente ni retrasar la atención en salud cuando esta sea urgente.

La adecuada aplicación del consentimiento informado no depende únicamente del cumplimiento normativo, sino del actuar ético y profesional del talento humano en salud. En este sentido, su intervención resulta determinante para garantizar que la información sea clara, comprensible y respetuosa de la autonomía de la persona. En este marco, el talento humano en salud tiene la responsabilidad de:

- Proporcionar información adecuada, veraz y comprensible.
- Verificar la comprensión de la persona antes de solicitar el consentimiento.
- Respetar las decisiones adoptadas, incluso cuando estas impliquen rechazar procedimientos.
- Registrar de manera clara el proceso de consentimiento informado en la historia clínica.

La adecuada aplicación del consentimiento informado contribuye a prevenir la revictimización institucional, fortalece la relación de confianza entre la persona y los servicios de salud y garantiza que la atención se brinde conforme a los principios de derechos humanos, ética profesional y normativa vigente.

7.3 Manejo ético de la información

El manejo ético de la información es un componente esencial de la atención integral en salud a personas víctimas de violencias sexuales. La información clínica, personal y sensible asociada a la atención debe ser protegida de manera estricta, garantizando la confidencialidad, la reserva y el uso adecuado de los datos, conforme a la normativa vigente y a los principios éticos del sector salud.

En este contexto, la normativa del sector salud establece que la historia clínica es un documento reservado, cuyo acceso y uso se limita exclusivamente a los fines autorizados. Este principio es fundamental para generar confianza en los servicios de salud y prevenir nuevas vulneraciones o situaciones de revictimización.

En este contexto, el manejo ético de la información se concreta en las siguientes responsabilidades del talento humano en salud:

- a.** Proteger la confidencialidad de la información clínica y personal de la persona víctima.
- b.** Restringir el acceso a la historia clínica únicamente al personal autorizado.
- c.** Evitar la divulgación indebida de información, tanto dentro como fuera del servicio de salud.
- d.** Abstenerse de realizar comentarios, registros o comunicaciones innecesarias que expongan a la persona.

En relación con el intercambio de información con otros sectores, se debe:

- Solo cuando esté autorizado por la normativa vigente.
- Bajo criterios de necesidad, pertinencia y proporcionalidad.
- Respetando la voluntad y la autonomía de la persona víctima, cuando sea aplicable.

Asimismo, en la elaboración de los registros clínicos exige que estos:

- Sean claros, objetivos y pertinentes.
- Se limiten a los hallazgos clínicos y decisiones asistenciales.
- Eviten juicios de valor o expresiones que afecten la dignidad de la persona.

El cumplimiento de estos principios contribuye a una atención respetuosa, segura y centrada en los derechos de las personas víctimas de violencias sexuales.

7.4 Responsabilidad ética y legal del talento humano

El talento humano en salud tiene una responsabilidad ética y legal indelegable en la atención integral de las personas víctimas de violencias sexuales. Esta responsabilidad se deriva de los principios constitucionales, la normativa vigente y los estándares éticos que orientan el ejercicio profesional en el sector salud.

Desde el punto de vista legal, el talento humano debe:

- Garantizar una atención integral, oportuna y sin barreras.
- Aplicar los protocolos, modelos y lineamientos técnicos vigentes.
- Respetar los derechos de las personas víctimas durante todo el proceso de atención.
- Cumplir con las obligaciones de registro, notificación y articulación institucional cuando corresponda.

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles o penales, según lo establecido en la normativa aplicable.

Desde la dimensión ética, la actuación del talento humano en salud debe fundamentarse en:

- El respeto por la dignidad humana.
- La autonomía y la toma de decisiones informadas.
- La confidencialidad de la información.

- El principio de no maleficencia y la prevención de la revictimización.

Esta responsabilidad ética implica una atención basada en la empatía, el respeto, la sensibilidad frente a la experiencia de violencia y el compromiso con la protección de la salud integral de la persona.

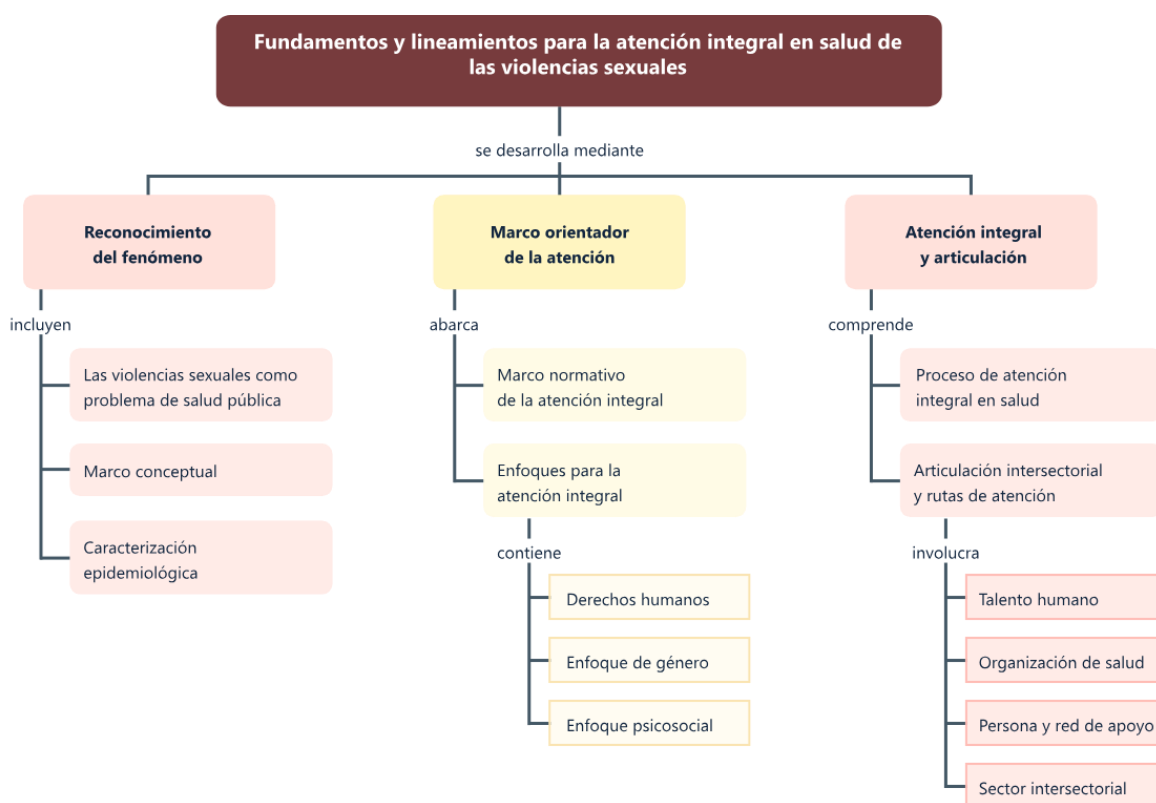
Adicionalmente, el talento humano en salud tiene la obligación de:

- Mantener actualizados sus conocimientos y competencias.
- Actuar conforme a la evidencia científica y la normativa vigente.
- Contribuir activamente a la calidad y humanización de la atención.
- Fortalecer prácticas institucionales orientadas a la protección de derechos.

En conjunto, la responsabilidad ética y legal del talento humano constituye un pilar fundamental para garantizar una atención integral, digna y ajustada a los estándares técnicos y normativos en la atención a personas víctimas de violencias sexuales.

Síntesis

Este componente formativo aborda los fundamentos y lineamientos que orientan la atención integral en salud frente a las violencias sexuales en Colombia. Se reflexiona sobre su impacto en la salud de las víctimas, el marco normativo vigente y los enfoques de derechos humanos, género y psicosocial que guían cada intervención. Asimismo, se desarrollan los procesos clínicos esenciales y las competencias éticas del talento humano para garantizar una atención humanizada, digna e intersectorial. A continuación, se presenta el mapa conceptual que ilustra de manera visual la estructura del componente formativo y las relaciones entre sus ejes temáticos.



Glosario

Articulación intersectorial: coordinación entre el sector salud y otras entidades del Estado para garantizar la protección y atención integral de las víctimas de violencias sexuales.

Autonomía: capacidad de la persona para tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su salud, sin presiones ni imposiciones.

Confidencialidad: obligación ética y legal de proteger la información personal y clínica de la víctima, limitando su acceso al personal directamente involucrado en la atención.

Consentimiento informado: aceptación libre y voluntaria de la persona para recibir un procedimiento o intervención en salud, luego de recibir información clara y comprensible.

Enfoque de derechos humanos: perspectiva que reconoce a las víctimas como sujetas de derechos y orienta la atención hacia su protección y restablecimiento, sin discriminación.

Enfoque de género: perspectiva que analiza cómo las desigualdades y relaciones de poder influyen en la ocurrencia de las violencias sexuales y en el acceso a la atención.

Enfoque diferencial: reconocimiento de las particularidades de cada persona, edad, género, etnia y discapacidad para brindar una atención pertinente y equitativa.

Enfoque psicosocial: consideración de las dimensiones emocionales, psicológicas y sociales de la víctima, más allá de las afectaciones físicas.

Historia clínica: documento reservado donde se registran de forma clara y objetiva los datos de atención en salud, hallazgos clínicos e intervenciones realizadas.

Referencia: remisión de una persona a otro nivel de atención o servicio especializado cuando la complejidad del caso o el riesgo identificado lo requieren.

Revictimización: daño emocional, psicológico o social que sufre la víctima como consecuencia de prácticas institucionales inadecuadas durante la atención.

Talento humano en salud: personas que, desde distintos roles y niveles de formación, participan en la prestación de servicios de salud y en la atención integral a las víctimas.

Trato digno: atención basada en el respeto, la empatía y el reconocimiento de la persona como sujeta de derechos, libre de discriminación o juicio moral.

Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 360 de 1997. Delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana.

Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano.

Congreso de la República de Colombia. (2004). Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal.

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia.

Congreso de la República de Colombia. (2007). Ley 1146 de 2007. Prevención de la violencia sexual y atención integral a NNA.

Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1257 de 2008. Violencia y discriminación contra las mujeres.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará. (1994).

<https://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp>

Corporación Humanas. (2009). Guía para llevar casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

Defensoría del Pueblo & Profamilia. (2007). Módulo de la A a la Z en derechos sexuales y reproductivos.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2009). Instructivo para manejo de kits de toma de muestras en delitos sexuales.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2009). Reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual (Versión 03).

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2010). CIE-10 aplicado a violencia sexual.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2009). Forensis: Datos para la vida.

Ministerio de la Protección Social. (2000). Resolución 412 de 2000. Guías de atención: mujer y menor maltratado.

Ministerio de la Protección Social. (2007). Decreto 3039 de 2007. Plan Nacional de Salud Pública.

Ministerio de la Protección Social & UNFPA. (2011). Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2011). Modelo y protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Lineamientos técnicos y operativos para la atención integral a víctimas de violencias sexuales.

Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Naciones Unidas. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Organización Mundial de la Salud. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/67411>

Organización Mundial de la Salud. (2003). Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence.

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/42788>

Organización Panamericana de la Salud. (2000). Promoción de la salud sexual: recomendaciones para la acción.

https://www.paho.org/sites/default/files/promocion_salud_sexual.pdf

Organización Internacional para las Migraciones. (2006). Dimensiones de la trata de personas en Colombia. <https://publications.iom.int/books/dimensiones-de-la-trata-de-personas-en-colombia>

UNICEF. (2002). Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Liliana M. Támara P.	Experta temática	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Osana Medina Bonilla	Experta temática	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Juan Camilo González	Asesor pedagógico	Ministerio de Salud y Protección Social
María Helena Tamayo	Asesora pedagógica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud. Regional Distrito Capital
Laura Brigitte Perea Possos	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gloria Lida Alzate Suárez	Evaluada instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Manuel Felipe Echavarria Orozco	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
María Fernanda Pineda Mora	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima